جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) * **طلب علاج أول مرة / متردد**

إسم المريض رباعياً : سماح حسين عبدالقادر داود
المحافظة : الجيزه **الحي / المدينة :** سته اكتوبر **العنوان :** حدائق الياسمين
رقم البطاقة : 28102151803001 **رقم التليفون :** 01061620131 **تاريخ تسجيل الإستمارة :** 17-10-2026
العمر(تاريخ الميلاد) : 15-02-1981 **المهنة :** ربه منزل

الإقرار

أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع باي نظام علاج مثل:-التأمين الصحي-القوات المسلحه-الشرطة-الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك

الإخصائي الاجتماعي **المقر بما فيه**
التوقيع:(----------) **التوقيع:**(----------)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)
نتائج الأبحاث : (مرفق)
التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)
خطة العلاج : علاج مبادرة سرطان الثدي علاج تدعيمي وتلطيفي [6579] **قسم العلاج :** الاورام
التعليق على التشخيص : ----------

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم: د/محمد كيلاني **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------
الاسم: د/ندى حسن **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------
الاسم: د/نرمين رمضان **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------

أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية.
كما تقر اللجنة بأن البيانات المدونة فى هذا النموذج صحيحة.

تعتمد صحة الإجابات المرفقة
رئيس اللجنة و مدير المستشفي.

تتعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفي قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

ا.د/ ---------- **ا.د/** ---------- **د/** ---------- **د/** ----------

قرار اللجنة

التشخيص النهائي : ----------
خطة العلاج : ----------
المستشفي : ----------**قسم :** ----------
جهة العلاج : ----------**نفقات :** ----------
ملاحظات : ----------

رئيس	مدير عام	ختم
المجلس الطبي المتخصص	مديرية الشئون الصحية	شعار الجمهورية

Name: سماح حسين عبدالقادر داود
National ID: 28102151803001

تقرير طبي

السيد

تحية طيبة وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	بشأن تقرير طبي للمريض
بقسم:	رقم طبي:

نتشرف بأن نوضح فيما يلي تقريرا عن حالته

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	تاريخ وساعة الخروج : PM 01:17 05-07-2026

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انة

المريضة تعاني من ورم غير حميد بالثدى و تحتاج الي Supportive and palliative Treatment

التاريخ : 05-07-2026	الوقت : -- --:--
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين



DMS

عليل وتحويل

مدكيم

بلاو



٦٣٥٤

National ID - Front & Back
[[DOCTYPE:ID_FRONT_BACK]]

GUSTAVE ROUSSY
INTERNATIONAL

Patient Name	: الأستاذه / سماح حسين عبد القادر داود	Request No.	: 13005750
Patient No.	: 28102151803001	Request Date	: 07/04/2026
Path No.	: 919/26	Verification Date	: 21/04/2026
Sex	: Female	Financial Category	: جوستاف روسي - نفقة الدولة
Age	: 45 Y	Department	: Out Patient
Referreing Doc	:	Registered by	: .marwa mohamed youss

Pathology Report

Clinical Data: Left breast cancer, Post-NACT.
Nature of Specimen: Left modified radical mastectomy.

Gross Examination:
* Left modified radical mastectomy specimen measured 24x16x7 cm, with covering skin ellipse measured 23x13 cm. Nipple & areola looked unremarkable grossly.
* Serialling showed a tumor bed site measured 7x6x3 cm, located 2 cm from the least deep margin.
* Axillary fat entangling 15 lymph nodes, the largest measured 1.5x1x0.5 cm.
* 14 Blocks:
1:7- TBS., 8- N&A., 9- Deep margin., 10:14- ALNs.
- Gross was done by; Dr. Heba Hassan.

Microscopic Examination:
* Histological type: No residual viable remnants of the previously diagnosed parenchymal invasive tumor.
- Cellularity (0%).
* Angioinvasion: Absent.
* Ductal carcinoma in situ: Absent.
* Nipple & areola: Free.
* Deep margin: Free.
* Axillary lymph nodes: Fifteen lymph nodes free of metastatic deposits (0/15).
* Histologic response to therapy: Pathological complete response to therapy.

Diagnosis:
Left breast cancer (Post-NACT), Left modified radical mastectomy:
- No residual viable remnants of the previously diagnosed parenchymal invasive tumor.
- Ductal carcinoma in situ: Absent.

Verified by :
Dr.Duaa Mohamed

CAP ACCREDITED
غرفة رقم (4) – الدور الأول – مبنى رقم (987) – كورنيش النيل – مصر القديمة – القاهرة – مصر
Room No. (4) - First Floor-Building No. 987- Nile Corniche - Misr El Qadema - Cairo, Egypt

Pathology Report
[[DOCTYPE:PATHOLOGY_REPORT]]

Name: سماح حسين عبدالقادر داود **MR. :** 6353	

Detailed Medical Report

السيد	

تحية طيبة وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من		بشأن تقرير طبي للمريض	
بقسم:		رقم طبي:	

نتشرف بأن نوضح فيما يلي تقريرا عن حالته

تاريخ وساعة الدخول :		تاريخ وساعة الخروج :	

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه

PREMENOPAUSAL LEFT BREAST CT3 N3 M0 ER 8/8 PR8/8 HER2 3+ CLIPS INSETED SA 1.8 ECHO EF 69 1/12 FOR NEOAD C6 TAXOTERE 135 MG , CARBOPL AUC 5 C6 PHESGO PENDING APPROVAL

today for C8 phesigo 600-600 as neoadj ECHO 30-3-2026 >> 66%

TRIPLE POSITIVE BREAST CANCER ER8/8 , PR 8/8 , HER2+3 . RECIVED NEOADJ CHEMO/PHESGO , DONE LT MRM , BIOBSY DCIS NIPPLE AND AREOLA FREE , AXILARY LN 0/15 YPT0 , YPTN0 MDT DATED 5/3/2026 : FOR ADJ PHESGO UP TO 17 CYCLES , PORT, AND ADJ FEMARA / ZOLADEX FOR 7 YRS APPROVALS FOR HORMONAL TTT AND PHESGO REQ RT REPORT DONE

for c9 phesgo + femara + zoladex c10 & c11 at pharmacy

c10 phesgo, echo 20/7 66 % EF c11. 12 pharmacy + femara

تحريرا في ,

التاريخ :	19-09-2026	الوقت :	

الطبيب المعالج : dina makram

يعتمد ,

GUSTAVE ROUSSY
INTERNATIONAL CENTER

Patient Name	: الأستاذه / سماح حسين عبد القادر داود	Request No.	: 13005750
Patient No.	: 28102151803001	Request Date	: 07/04/2026
Path No.	: 919/26	Verification Date	: 21/04/2026
Sex	: Female	Financial Category	: جوستاف روسي - نفقة الدولة
Age	: 45 Y	Department	: Out Patient
Referreing Doc	:	Registered by	: .marwa mohamed youss

Pathology Report

- Nipple & areola: Free.
- Deep margin: Free.
- Axillary lymph nodes: Fifteen lymph nodes free of metastatic deposits (0/15).
- Stage: ypT0, ypN0.

Signature
Dr. Walaa Ibrahim Ghoneim.

Verified by :
Dr.Duaa Mohamed

CAP ACCREDITED
غرفة رقم (4) – الدور الأول – مبنى رقم (987) – كورنيش النيل – مصر القديمة – القاهرة – مصر
Room No. (4) - First Floor-Building No. 987- Nile Corniche - Misr El Qadema - Cairo, Egypt

Pathology Report
[[DOCTYPE:PATHOLOGY_REPORT]]

Patient ID: 93397	Patient Name English: Samah Hussein Abdalkader
Age: ٤٢ سنة, ١١ شهر	2026/02/15 02:09:27 PM :Report Date

Contrast enhanced Spectral Mammography

CLINICAL SUMMARY: a female patient with pathologically proven left invasive ductal carcinoma grade II

CC & MLO low energy & recombined (post contrast) images

FINDINGS:

Background Uptake: Minimal background enhancement.

ACR: C (heterogenous dense)

Left breast:

- **Low energy (Non contrast) images:** left breast shows middle 1/3 UIQ clip with foci of calcifications seen anterior to the clip about 2.5 cm and posterior to the clip about 2 cm
- **Recombined (Post contrast) images:**
  - **Left breast show clip with no underlying mass enhancement, with related two enhancing foci seen anterior and posterior to the clip (corresponding to the calcifications)**
    - **Anterior measuring about 7x 6 mm and area of non-mass enhancement seen anterior to enhancing focus measuring about 1.3x1.2 cm. measuring collectively about 2.5x2.3 cm about 2 from the skin and 5 CMFN**
    - **Posterior enhancing focus to the clip measuring about 7.5x7 mm 6 cm from the skin and 7 CMFN**
  - **No other mass lesions or abnormal enhancement**
- **Complementary US:**
  - **The left breast shows large irregular shaped isoechoic lesion located at 11:00 clock position 2 CMFM measuring about 2x0.5 cm**
  - **Another hypoechoic lesion seen at 10 o'clock measuring about 7x5 mm**
  - **Few small cysts 12 o'clock cysts seen some of which seen complicated**
  - **The scanned axillary lymph nodes are seen with normal cortical thickness and oval in shape**

Right breast:

- **Low energy (Non contrast) images** No asymmetry or distortion or suspicious microcalcifications.
- **Recombined (Post contrast) images:** no pathological mass or non-mass enhancement.
- Normal skin / nipple / areolar complex.
- **Complementary ultrasound:**
  - No solid or cystic lesions.
  - No enlarged axillary LNs.

IMPRESSION:

- **LEFT BREAST:** (BIRADS 6= pathological proven) LEFT UOQ multifocal enhancing statiltes corresponding to the calcifications with clip in-between yet the index lesion shows no enhancement (post therapeutic effect) .for preoperative localization and bracketing
- **RIGHT BREAST**: (BIRADS 2) normal study.

Norhan osama,MD

Mammogram
[[DOCTYPE:MAMMOGRAM]]

BOHEYA

Radiology Department

بهية

قسم الأشعة التشخيصية

PATIENT NAME: SAMAH HUSEN ABD EL KADER DAWOD
GENDER: Female
DATE : 06-Aug-2025 11:59 AM

PATIENT ID: 20225022073
AGE: 44 y
ORDER: Z230760,Z230761

FULL FIELD DIGITAL MAMMOGRAPHY AND COMPLEMENTARY ULTRASOUND

INDICATION:

- Left breast lump.

TECHNIQUE:

- CC and MLO view.
- Complementary ultrasound

REPORT:

- ACR:B
- Mottling appearance of the parenchyma with bilateral scattered anechoic cysts.

Left breast:

- UIQ middle third indistinct lesion with surrounding parenchymal distortion with posterior extension and overlying microcalcifications ,covering an area of 5.6X3.1 cm ,about 2.3 cm from the nipple.
- UOQ and UIQ clusters of micro-calcfications extending to the nipple.
- **Complementary US revealing:**
- 10 to 11 o'clock irregular hypoechoic lesion with intraductal extension showing irregular lesions, medially related to the main lesion, collectively measuring 4X1.8 cm about 3 mm depth from the skin.
- Multiple pathologically enlarged level 2 and 3 axillary lymph nodes, the largest measures 2.6X1.3 cm.
- Single enlarged left supraclavicular lymph node measures 1.5X0.7 cm.

Right breast:

- Scattered loose groups of microcalcifications.
- No spiculated mass lesions.
- No solid mass lesions.
- Normal skin thickness and contour.
- Normal nipple areola complexes.
- Nonspecific axillary lymph nodes.

OPINION:

- Left breast UIQ malignant mass lesion with ipsilateral group II and III axially lymphadenopathy as well as left supra-clavicular lymph node(BIRASD 5) for histopathological correlation.
- Left breast UOQ and UIQ clusters of micro-calcfications (BIRADS 4a).
- Right breast fibrocystic changes (BIRADS 2).

RECOMMENDATION:

مركز بهية الهرم
4 شارع علوية أول شارع الهرم بجوار بارى , الجيزة

Mammogram
[[DOCTYPE:MAMMOGRAM]]

STAVE/
USSY
ATIONAL

Patient Name	: الأستاذه / سماح حسين عبد القادر داود	Request No.	: 13004553
Patient No.	: 28102151803001	Request Date	: 25/08/2025
ath No.	: SR-1172/25	Verification Date	: 28/08/2025
Sex	: Female	Financial Category	: جوستاف روسي - نفقة الدولة
Age	: 44 Y	Department	: Out Patient
Referreing Doc :		Registered by	: .marwa mohamed youss

Pathology Report

Clinical Data: Left breast mass.
Nature of Specimen: Referred block & slides (Tru-cut biopsy).

Gross Examination:
One referred block labelled by (203065-25). Together with, three referred immunostained slides for (ER, PR & HER2neu).

Microscopic Examination:
* Histological type: Invasive duct carcinoma.
* Grade 3 (differentiation 3, nuclear pleomorphism 3, mitosis 2).
* Focal minimal low grade DCIS (Cribriform pattern).
* Angioinvasion: Present.
* Perineural invasion: Absent.

* IPT:
- ER: Strong nuclear reaction in 85% of tumor cells (score 8/8).
- PR: Strong nuclear reaction in 90% of tumor cells (score 8/8).
- Her2: Strong complete membrane reaction in more than 10% of tumor cells (score 3+).

Diagnosis:
Left breast mass, Referred block & slides (Tru-cut biopsy):
- Invasive duct carcinoma, Grade 3, with focal minimal low grade DCIS (Cribriform pattern).
IPT:
- ER: Positive (score 8/8).
- PR: Positive (score 8/8).
- Her2: Positive (score 3+).

* Scoring system: "ER, PR"

Verified by :
Dr.Duaa Mohamed

CAP ACCREDITED
غرفة رقم (4) – الدور الأول – مبنى رقم (987) – كورنيش النيل – مصر القديمة – القاهرة – مصر
Room No. (4) - First Floor-Building No. 987- Nile Corniche - Misr El Qadema - Cairo, Egypt

Pathology Report
[[DOCTYPE:PATHOLOGY_REPORT]]

STAVE/
USSY

atient Name	: الأستاذه / سماح حسين عبد القادر داود	Request No.	: 13004553
atient No.	: 28102151803001	Request Date	: 25/08/2025
ath No.	: SR-1172/25	Verification Date	: 28/08/2025
ex	: Female	Financial Category	: جوستاف روسي - نفقة الدولة
ge	: 44 Y	Department	: Out Patient
eferreing Doc :		Registered by	: .marwa mohamed youss

Pathology Report

ASCO-CAP ER/PR Test Guideline Recommendations: proportion of cells staining (0, no staining; 1, >1%; 2, between 1% and 10%; 3, between 11% and 33%; 4, between 34% and 66%
and 5, between 67%-100% of the cells staining). Intensity of positive tumor cells (0, none; 1, week, 2, intermediate; and 3, strong). Total score from 0 to 8.
* Scoring system: "Her2"
Reference: ASCO-CAP Her2 Test Guideline Recommendations, 2013.IHC 0: as defined by no staining observed or membrane staining that is incomplete and is faint/barely perceptible and within < 10% of the invasive tumor cells. IHC 1+: as defined by incomplete membrane staining that is faint/barely perceptible and within > 10% of the invasive tumor cells.
IHC 2+: based on circumferential membrane staining that is incomplete and/or weak/moderate and within >10% of
the invasive tumor cells or complete and circumferential membrane staining that is intense and within < 10% of the invasive tumor cells. IHC 3+: based on circumferential membrane staining that is complete, intense > 10% of tumor cells.

Signature
Dr. Walaa Ibrahem Ghoneim.
Dr. Heba El-Shafeey.

Verified by :
Dr.Duaa Mohamed

CAP ACCREDITED
غرفة رقم (4) – الدور الأول – مبنى رقم (987) – كورنيش النيل – مصر القديمة – القاهرة – مصر
Room No. (4) - First Floor-Building No. 987- Nile Corniche - Misr El Qadema - Cairo, Egypt

Pathology Report
[[DOCTYPE:PATHOLOGY_REPORT]]

PATIENT NAME: SAMAH HUSEN ABD EL KADER DAWOD
GENDER: Female
DATE : 20-Aug-2025 03:26 PM

PATIENT ID: 20225022073
AGE: 44 y
ORDER: Z238057,Z238058

POST CONTRAST MULTI-SLICE CT SCAN OF THE CHEST, ABDOMEN AND PELVIS WITH SPECIAL TRIPHASIC STUDY OF THE LIVER

TECHNIQUE:

- Multislice helical CT acquisition with automatic IV low osmolar non-ionic contrast medium infusion 60 ml.

FINDINGS:

1-CHEST

- Left breast upper inner quadrant ill-defined irregular faintly enhancing mass lesion is seen measuring about 2.4x 3.7 cm along its maximum axial dimensions.
- Pathologically enlarged left axillary level II and III lymph nodes, the largest is at level II, measures about 1.8 x 2.4 cm along its maximum axial dimensions and seen inseparable from the overlying left pectoralis minor muscle and abutting the underlying chest wall.
- Single pathologically enlarged left supraclavicular lymph node measures about 0.8 x 1.4 cm along its maximum axial dimensions.
- Small left internal mammary lymph node is seen measuring about 4 mm.
- No sizable pulmonary nodules, masses, areas of consolidation or cavitary lesions.
- Bilateral fine apical reticulations.
- No CT evidence of pathologically enlarged hilar or mediastinal lymph nodes.
- No evidence of pleural effusion, pleural thickening or masses seen.
- No gross cardiomegaly.
- No pericardial effusion detected.

2- ABDOMEN AND PELVIS

- The liver is of average size with homogenous CT texture. No pathologically enhancing focal lesions noted throughout different study phases.
- No intra-hepatic or extra-hepatic biliary radicles dilatation.
- Patent homogeneously enhancing portal vein and its main branches.

مركز بهية الهرم
4 شارع علوية أول شارع الهرم بجوار داري , الجيزة
مستشفى بهية الشيخ زايد
www.Baheya.org
16602

CT Scan
[[DOCTYPE:CT_SCAN]]

- Relatively thickened left suprarenal gland.
- Bulky uterus showing small anterior wall hypodense lesion likely representing fibroid, for US correlation.
- Left adnexal cyst is seen measuring about 3.8 x 4.5 cm along its maximum axial dimensions, for clinical and US correlation.
- Normal appearance of the pancreas, spleen, kidneys, right suprarenal gland, aorta (apart from small aortic atheromatous calcification), I.V.C and the rest of the pelvic organs.
- Smooth filling of the urinary bladder with no filling defects or diverticular outpouching.
- No pathologically enlarged abdominal or pelvic lymph nodes.
- No abdominal or pelvic masses or collections.
- **The revised bone window revealed:**

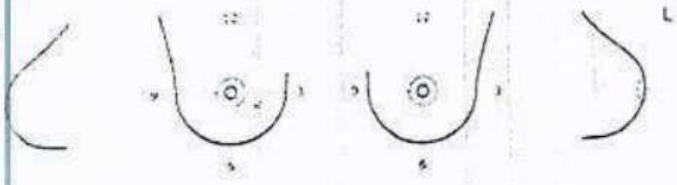
1. Dorsolumbar spondylosis with no CT evidence of vertebral collapse or extra-osseous soft tissue component.
2. Mild bilateral sacroiliitis.

Opinion:

- **Left breast malignant process with ipsilateral axillary and single supraclavicular lymphadenopathy, as described.**
- **No definite pulmonary or hepatic metastatic deposits.**

Reported By,
Dr. Nouran Atress,MSc
Dr. Marwa Ahmed, MD **21-Aug-2025 10:58 AM**

مركز بهية اليوم
CT Scan
[[DOCTYPE:CT_SCAN]]



CamScanner ممسوحة ضوئيا بـ

مركز بهية الهرم
٨ شارع علوبة قول شارع الهرم بجوار ناري . الجيزة
www.Baheya.org
16602
مستشفى بهية المشيخ زايد
٤ الحي الأول - الشيخ زايد أمام كلية الهندسة
Bone Scan
[[DOCTYPE BONE_SCAN]]

NILE
SCAN & LABS

Name : Samah Hussein Abdelkader
Branch : Dokki
Ref.Physician Prof : Gostaf Rosch Hospital

Date : 25-09-2025 12:45
Medical No. : 211207

$Tc^{99}m$ MDP SKELETAL SCINTIGRAPHY

History:

- 44-year-old lady, with history of left breast cancer.

Technique:

- Anterior and posterior whole body scans were acquired 2 hours post injection of the tracer.

Findings:

- No any abnormal active or cold focal bony lesions that may account for metastatic bone disease.
- Degenerative changes are seen at the spine and big joints.

Impression:

- The skeleton is free from metastases.

Best regards,
Dr. Alaa Nagi, MD
Nuclear Medicine

Bone Scan
[[DOCTYPE:BONE_SCAN]]

رقم التقرير : .....

مستشفيات جامعة القاهرة
إدارة الخدمات الإجتماعية
مركز قصر العيني لعلاج الأورام
والطب النووي

تقرير طبي بالخدمات الإجتماعية الطبية

اسم المريض : سماح حسين عبد القادر السن : ٤٥ المهنة : ..... القسم : عظام

رقم المستشفى : 7992 تاريخ الدخول / / ٢٠ تاريخ الخروج / / ٢٠

مازال تحت العلاج

التشخيص : المريضة تعاني من ورم خبيث بالثدي الأيسر وقد تم عمل استئصال الثدي مع الغدد الليمفاوية بتاريخ ٢٠٢٠/٦/٩ وتم عمل ٤ دورات كيماوي بالبروتوكول FEC100 وتم ايقاف العلاج بتاريخ ٢٠٢٠/٩/١٥ وتم عمل ٢٥ جلسة إشعاع بتاريخ ٢٠٢٠/٩/٢٤ وانتهت بتاريخ ٢٠٢١/٢/٦

التوصيات :

مشرفة القسم

الطبيب المعالج

تحريرا في ٢٠٢١/٩/٢٤

السيد الأستاذ / مدير مستشفى كوم الدلو

تتشرف بأن نعرض على سيادتكم التقرير الطبي للمريض المذكور .

برجاء التكرم باتخاذ اللازم نحو مساعدته دون أدنى مسئولية على المستشفى .

الأخصائي الإجتماعي

مدير الخدمة الإجتماعية

المدير